EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 83163
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 24-04-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA TRINIDAD GATICA JIMENEZ			RUN	: 3.827.886-K
F.Nac	: 29-03-1935	Edad	: 89 AÑOS	Género	: Femenino
Dirección	: FREIRE 640			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 412072		
Fecha Ingreso	: 2024-04-18	Fecha Egreso	: 24-04-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. ITU Baja
a. K. BLEE+ /E. Coli + en tratamiento
2. Episodio convulsivo
a.Epilepsia vascular
b. ACV isquémicos múltiples secuelados, lesion aguda descartada
3. Tumor de colon ascendente
a. Hemicolectomia Derecha 23.2.24
4. Cardiopatía Coronaria - Stent DA proximal y Med
5. FA Persistente
a. CHADVASC 3 puntos
b. HASBLED 5 puntos (riesgo de sangrado en 1 año 4.9- 19.6%)
6. HTA
7. DM2 NIR
8. Monorrena Quirurgica por TU renal.
9. Ateromatosis aortica
10. DLP

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. G40.9-EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. R56-CONVULSIONES NO ESPECIFICADAS EN OTRA PARTE (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I48-FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
6. E10-E14-DIABETES MALLITUS (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina de 89 años con antecedentes de hospitalizacion previa por evento de similares caracteristicas al actual, posterior al alta en buenas condiciones, hospitalizacion en febrero de 2024 por Hemicolectomia Derecha, por tumor de colon ascendente, Cardiopatía Coronaria que requirió manejo con Stent DA proximal mecanico y FA crónica en tratamiento con apixaban CHADVASC 3 puntos / HASBLED 5 puntos (riesgo de sangrado en 1 año 4.9- 19.6%), sin TACO, HTA, DM2 NIR Monorrena Quirurgica por TU renal. Ateromatosis aortica DLP. Epilepsia secundaria a acv antigua. Es traída traída al su de HSC el dia 17/04/22 por familiares quienes refieren despierta normal pero que entre las 9 a 10, inicia con afasia, mirada desviada a derecha y rigidez generalizada. al ingreso FC 105, PA 151/75, T° 36.6°C, Sat 99 % y HGT 148, paciente durante atención presentó convulsión tónico clónica de segundos de duracion, que cede con la administración de lorazepam, estado postictal. se inicia Levetiracetam 500 mg y se solicita evaluación de neurología, Dr. Venegas evalúa a paciente y refiere probable lesión del puente reciente, dado lo anterior sugiere hospitalizar y realizar

angiotac de cerebro. Exámenes de lab al ingreso sin alteraciones, tac de cerebro sin alteraciones agudas evidentes de momento, ateromatosis carotidea y vertebral sin foco estenotico significativo. Signos de ateromatosios intracraneana. se revisa en sistema pendiente realizar holter de arritmias, y ecocardio tomado sin evidencia examen en sistema. Paciente durante hospitalización, evoluciona en RCG, HDN estable, FA RVA, eupneica, afebril, tranquila, cooperadora, no refiere molestias, sin crisis convulsivas, se observa más reactiva que días previos, logra sedestación independiente, nivel y contenido de conciencia fluctuante compatible con delirium, Tolerando bien alimentación VO, sin nauseas o vomitos, disartria leve. evaluada por neurologia quien descarta lesion hemorragica aguda o isquemica de territorio encefalico, e indica seguir en controles en policlinico continuando tratamiento con levetiracetam, medicina interna evalúa a paciente por diagnostico de ITU baja quien inicialmente se encontraba en tratamiento con tazonam, en espera de urocultivo, que resulta positivo para K.Aerogenes BLEE + y E. Coli M.S, ajusta tratamiento antibiotico segun antibiograma, ertapenem 1gr EV c/d x 5 dias, por HODOM + proceso de rehabilitación motora y fonoaudiologica indicada por neurologia.

PLAN DE MANEJO:

- Alta domiciliaria con antibioticoterapia EV
- Paciente con cuadro neurologico en regresion, dada evolucion favorable, se decide alta neurológica, continuar uso de levetiracetam, y controles policlinico de neurologia
- paciente en contexto de FA permanente, requiere ACO, sin contraindicacion desde el punto neurologico se inicia rivaroxaban 20mg 1 comprimido por SNG c/d
- ITU klebsiella Blee +, mantener tratamiento en domicilio con ertapenem 1g ev al dia , completar 5 dias de tratamiento antibiotico efectivo en Hodom.

INDICACIONES AL ALTA

1. 1. Alta domiciliaria, seguimiento con HODOM
2. 2. Reposo relativo, movilizar y levantar asistido
3. 3. Régimen liviano hiposodico diabetico
4. 4. Ertapenem 1gr EV c/d por 5 dias
5. 5. levetiracetam 500 mg vo c/12 hrs
6. 6. bisoprolol 2,5 mg c/12 hrs
7. 7. losartan 50 mg vo c/12 hrs
8. 8. metformina 850 mg c/12 hrs con comidas
9. 9. Atorvastatina 40mg c/noche
10. 10. clopidogrel 75 mg vo dia
11. 11. rivaroxaban 20mg vo c/dia
12. 11. famotidina 40 mg vo dia
13. 12. Paracetamol 500mg 2 comp vo SOS
14. 13. Pendiente realizar holter de ritmo (realizar ambulatorio);
15. 14. Continuar control de patologías crónicas en poli medicina interna en 3 semanas
16. 15. Control con neurologia en 2 semanas
17. 16. En caso de signos de alarma: fiebre que no cede a antipiréticos, sangrados, compromiso de conciencia, habla traposa, convulsiones, consultar en servicio de urgencias

OBSERVACIONES:

Int Cristian Pérez
Dr. Jorge Villa Flores

Control en: 14 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Jorge Andres Villa Flores
MEDICO TRATANTE
16178692-6

JEFE SERVICIO